

Sabato 25 marzo 1972.

Reparto 21 - Infettivi.

Reparto chiuso.

Posti letto 100: sez. uomini 79

donne 21

Ricoverati al 1° marzo: 52 - uomini 45

donne 7

Infermieri e guardie: sez. uomini 18 (in due turni di 9; però per la
rotazione delle ferie, eventuali malattie ed al-
tre assenze, effettivamente presenti: 4 o 5.

non vengono sostituiti nei suddetti casi, perchè

ai sostituti non è concessa l'indennità di conta-
gio.)

Infermiere: sez. donne 12 (in due turni di 6; però per i suddetti mo-
tivi la presenza effettiva è di 2.)

1 Capo - 1 Sottocapo.

Gli infermieri hanno compito di vigilanza, il Capo e il Sottocapo fan-
no funzionare il Reparto, coordinano le attività. Hanno accesso alle
certelle cliniche, ma non se ne interessano, in quanto non svolgono
compiti terapeutici.

Il reparto è in fase di miglioramento: rifornito in guardaroba, for-
niti armadietti, rinnovati e funzionanti i servizi igienici della sez.
femminile, rinnovati in parte quelli della sez. masch., dati in appal-
to i lavori per gli altri. Sbarre alle finestre (il medico di rep. tut-
tavia ne aveva disposto la eliminazione).

Il vitto è speciale: carne a tutti i pasti, aggiunta di formaggio o marmellata, sempre frutta.

Non c'è bar: solo un distributore di bevande calde.

I ricoverati sono affetti per lo più da tbc (polmonare, ossea, del metacarpo, morbo di Pott) o da altre malattie infettive (es., epatite virale). C'è possibilità di isolamento.

Vengono qui inviati da tutti i reparti dell' O.P. per richiesta del malato stesso o su segnalazione degli infermieri.

Guariti - non pare previsto un periodo di convalescenza - vengono rimandati ai reparti di provenienza, previ gli esami e gli accertamenti del caso.

Nessun ricoverato svolge lavori all'esterno del reparto.

23 su 52 circa si occupano delle pulizie all'interno insieme con gli infermieri (il Sottocapo asserisce tuttavia che non tutti svolgono incombenze effettive: sono stati messi sotto decade, L.300 o 500 giornaliera, perchè privi di pensione).

I ricoverati dispongono di un televisore e di un cortile interno, in cui passeggiare o giocare a bocce; qualcuno gioca a carte, qualcuno legge. Pochissimi, in fase non contagiosa, escono all'esterno del Reparto. In genere tutti riposano molto, data la natura della malattia fisica.

Nessun ammalato è contenuto (almeno da 9 mesi ad oggi).

Non c'è nè psicologo nè assistente sociale. Non sembrano esistere situazioni di conflitto tra medico e infermieri. (1)

(Informazioni desunte dal colloquio con il Sottocapo infermieri)

(1) Il Med. ⁶ presente in rep. 2 ore circa al matt. e 2 al pomeriggio. (si occupa anche del rep. 15, chirurgia).

Il Reparto è Sanatoriale, prevale quindi la cura dell'affezione tubercolare, per cui vengono usati tutti gli specifici anche se costosi e recenti.

La terapia mentale, ove sia possibile è necessaria, è specialmente farmacologica: usati timolettici, antidepressivi e, solo con estrema cautela, neuroplegici. Escluso l'elettrochoc.

Sono presenti nel reparto malati mentali di ogni genere (epilettici, schizofrenici, arteriosclerotici gravi), senza distinzione, perchè la particolare natura del rep. non lo consente; molti sono anziani (la tbc senile è in aumento) e tutti piuttosto gravemente deteriorati nel fisico (la tbc si instaura appunto in organismi che hanno sofferto di carenze alimentari ed igieniche o minati dall'alcolismo); anche mentalmente sono perciò gravemente deteriorati; sono spesso presenti le forme terminali della malattia.

Nei casi in cui è possibile, circa 12, degenti, è applicata la psicoterapia dal medico di reparto, psichiatra e fisiologo, nelle forme della narcoanalisi e della terapia di sostegno.

In un discorso generale, il medico asserisce che l'origine delle malattie mentali è complessa e vi concorrono fattori endogeni, ereditari, acquisiti, non esclusi quelli sociali, che non sono però né gli unici né i determinanti.

Riconosce che per il passato il ricupero del malato si limitava alla dimissione e che tutt'al più si cercava di persuaderlo a ricorrere periodicamente al Centro di Igiene Mentale.

Ad una domanda precisa se riconosca utile il regime assembleare e se

ne abbia fatto esperimento, il Medico risponde affermativamente, ma sorvola. Insiste piuttosto sul rapporto di fiducia che deve instaurarsi tra medico, ammalati, infermieri, e sulla rimozione di motivi di ostilità dovuti, per es., a presenza di inferriate, a ricoveri violenti e brutali.

(Informazioni desunte dal colloquio con il Medico di Rep. Dr. D'Alba)

Durante il colloquio (con il sottocapo infermieri ha telefonato il Dr. Mossa, che, chiesto chi fossimo e che cosa facessimo, ha dato ordine perentorio di non fare entrare nessuno in Rep. se non accompagnato dal Medico). La stessa cosa ci è stata ripetuta dal Dr. D'Alba, che ci ha pure comunicato che il Direttore desiderava parlarci.

Preso visione della fotocopia del Verb. d'Adunanza del Consiglio d'Amministrazione degli O.O.P.P. di Torino in data 15/12/71, che affermava di non conoscere, il Dr. Mossa non ha fatto ulteriori opposizioni, ammonendo tuttavia di fare attenzione a quello che si faceva e asserendo che "se la psichiatria appartiene alla medicina sia lasciata ai medici".

L'infermiere ha informato che nel rep. 21 è stata di recente una commissione di psichiatri (voluta o mandata dalla Provincia) che ha preso visione di tutte le cartelle cliniche a scopo di censimento.

Emilia Beni